UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Gynécologie médicale
Difficulté à procréer
sans patient
sans geste clinique

Nom du rédacteur : Lacroix Louise **Date de rédaction : 03/12/2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 33 : Difficulté à procréer + N°229 : Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen d'imagerie médicale SDD-229

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Prescrire le bilan de première intention d'infertilité féminine : bilan hormonal, d'imagerie pelvienne

2- Prescrire un spermogramme et interpréter les résultats

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Résultats d'examens : spermogramme normal, bilan bio normal, hystérosalpingographie anormale avec compte rendu

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en gynécologie. Vous recevez les résultats d'examen d'un couple ayant consulté pour infertilité après 12 mois de rapports sexuels réguliers sans contraception : bilan biologique, spermogramme, hystérosalpingographie.
La femme est G0P0 et n'a pas d'antécédent de chirurgie pelvienne.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Interpréter le bilan biologique et les 2 imageries.
2. Synthétiser les examens paracliniques.
3. Formuler deux hypothèses diagnostiques.

Vous NE devez PAS faire d'interrogatoire NI d'examen physique.
Vous ne devez pas faire le bilan pré-conceptionnel.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Enonce que les taux hormonaux chez la femme sont normaux : - LH - Œstradiol - FSH - TSHus	
Enonce que les follicules antraux sont en nombre suffisant	
Enonce que l'échographie endopelvienne est normale	
Enonce la trompe droite et la trompe gauche sont obstruées OU obstruction tubaire bilatérale OU imperméabilité des deux trompes	
Enonce que le produit de contraste ne diffuse pas dans la trompe droite ni dans la trompe gauche OU que le PDC ne diffuse pas de manière bilatérale	
Enonce que le produit de contraste diffuse dans la cavité utérine ET le vagin OU dans l'utérus ET le vagin	
Enonce que la cavité utérine ET le vagin sont normaux OU que l'utérus ET le vagin sont normaux	
Tache 2	
Rappelle que le bilan biologique de la femme est normal	
Enonce que le spermogramme ET le spermocytogramme sont normaux	
Enonce que l'hystérosalpingographie est ANORMALE	
Rappelle que le compte des follicules antraux est normal	
Tache 3	
Formule l'hypothèse diagnostique : adhérence tubaire OU adhérence annexielle OU séquelle/antécédent d'infection génitale haute OU séquelles / antécédent d'IGH OU ATCD/séquelles de salpingite	
Formule l'hypothèse diagnostique : endométriose	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à la synthèse des données	1 à 5

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération
Tache 1	
Enonce que les taux hormonaux chez la femme sont normaux : - LH - Œstradiol - FSH - TSHus	1
Enonce que les follicules antraux sont en nombre suffisant	2
Enonce que l'échographie endopelvienne est normale	1
Enonce que le produit de contraste ne diffuse pas dans la trompe droite ni dans la trompe gauche OU que le PDC ne diffuse pas de manière bilatérale	2
Enonce la trompe droite et la trompe gauche sont obstruées OU obstruction tubaire bilatérale OU imperméabilité tubaire	2
Enonce que le produit de contraste diffuse dans la cavité utérine ET le vagin OU dans l'utérus ET le vagin	2
Enonce que la cavité utérine ET le vagin sont normaux OU que l'utérus ET le vagin sont normaux	1
Tache 2	
Rappelle que le bilan biologique de la femme est normal	1
Enonce que le spermogramme ET le spermocytogramme sont normaux	1
Enonce que l'hystérosalpingographie est ANORMALE	1
Rappelle que le compte des follicules antraux est normal	1
Tache 3	
Formule l'hypothèse diagnostique : adhérence tubaire OU adhérence annexielle OU séquelle/antécédent d'infection génitale haute OU séquelles / antécédent d'IGH OU ATCD/séquelles de salpingite	3
Formule l'hypothèse diagnostique : endométriose	3
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à la synthèse des données	1 à 5

SOURCES

Paramètres	Normes	Anomalies
Volume spermatique	N ≥ 1,4 mL	Absence d'éjaculat : aspermie ↓ : Hypospermie
pH du sperme	7,2 ≤ N ≤ 8	↓ : Sperme acide ↑ : Sperme alcalin
Numération	N ≥ 16 millions/mL (concentration) N ≥ 39 millions/éjac	↓ : Oligozoospermie Absence de spz = Azoospermie
Mobilité à 1 heure	totale (PR+NP) ≥ 42% progressive (PR) ≥ 30%	↓ : Asthénozoospermie
Vitalité	N ≥ 58%	↓ : Nécrozoospermie
Morphologie	Spz typiques ≥ 4% (selon classification de Krüger) Spz typiques ≥ 23% (selon classification de David modifiée)	↓ : Tératozoospermie
Leucocytes	N < 1 million/mL	↑ Leucospermie

Bilan de 1re intention chez la femme

- **Bilan biologique (J2 à J4 du cycle) : FSH, LH, œstradiol** ; complété en fonction du contexte : AMH si suspicion de diminution de la réserve ovarienne (âge > 35 ans), prolactinémie, TSH si troubles du cycle, 17OH-progestérone et testostérone totale si hyperandrogénie clinique (hirsutisme)
- **Échographie pelvienne par voie endo-vaginale** avec compte des petits follicules pré-antraux à J2-J3 du cycle
- Bilan tubaire : **hystérosalpingographie** en 1re partie de cycle ± hystéroscopie et cœlioscopie diagnostique en 2e intention
- Sérologies pré-grossesse et pré-AMP : VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C, toxoplasmose, rubéole + varicelle en l'absence d'antécédent clinique

Bilan de 1re intention chez l'homme

- Spermogramme (contrôle 3 mois après en cas d'anomalies), spermocytogramme
- ± Spermoculture si antécédents infectieux
- Sérologies : VIH, syphilis, hépatite B, hépatite C

Bilan du couple

± Test post-coïtal en phase pré-ovulatoire (J12 du cycle), dont l'intérêt (tout comme celui de la courbe de température) est très discuté par les médecins de la reproduction

*Ne pas oublier le **bilan préconceptionnel** avec la mise à jour des vaccinations et des conseils de mesures hygiéno-diététiques préconceptionnelles (arrêt du tabac, supplémentation en acide folique, etc.)*